

31. 横隔膜プラクティス - 3つのテクニック

所要時間 : 16:09

学習シート

コース概要

このビデオでは、呼吸機能と患者、特に子供の全身状態を改善するために不可欠な、横隔膜を解放する2つのテクニックを紹介しています。最初のテクニックは、食道と横隔膜の接合部に焦点を当て、螺旋状の動きと組織の傾聴を利用して横隔膜の圧力を解放します。詳細な実践プロトコルには、首の評価、弛緩、可動化の段階が含まれており、動きの自由を取り戻すことを目的としています。2番目のテクニックは、大網の後腔と食道の付着部を対象とし、肋骨と横隔膜の相互作用の重要性を強調しています。これらのアプローチは、生体力学的実践に根ざしており、患者の全体的な幸福を目指しています。

横隔膜の実践 - 3つのテクニック

横隔膜テクニックの紹介

主に2つのテクニックを探索します。1つ目は、横隔膜の空間を解放するための**機械的**アプローチです。2つ目は、特に子供や乳幼児において**最適な拡張**を取り戻すための、横隔膜への**全体的**アプローチです。このテクニックは**生体力学的**な実践に属します。

テクニック1：食道と横隔膜の接合部の解放

食道と横隔膜の**交差点**に特化して取り組みます。この領域は、特に**迷走神経**の幹を含む**神経ネットワーク**が豊富です。目標は、この領域を優しく解放することであり、これにより周囲の迷走神経領域全体が解放されます。

主要な解剖学

- 横隔膜の右側と左側を観察します。
- 胸膜**もここに存在します。
- かつて静脈であった**トレイツ・レーマー静脈**という解剖学的痕跡があります。
- 小さな筋肉が横隔膜と腹膜に付着し、**食道周囲**の空間を形成しています。この空間は、横隔膜の接合部に対する適応性と再平衡化の機能を持っています。

- この構造は、十二指腸の懸垂靱帯である**トレイツ筋**に続いています。

身体の螺旋運動

身体はしばしば**螺旋**状に組織されており、これはどこにでも見られる強力な動きです。胚自体も螺旋運動に従って発達します。私たちはエネルギー療法で螺旋を使って特定のポイントをターゲットにします。ここでは、この螺旋運動の原理を適用します。

実践プロトコル

1. **位置特定：** 胃の最も高い部分にアクセスできる接合部のレベルに位置します。

2. **首の予備テスト：**

- 頭を左に回し、感覚を感じます。
- 中央に戻り、次に頭を右に回します。
- 中央に戻り、再び頭を左に回します。回転が制限されているかどうかを確認します。多くの場合、この横隔膜領域が首の良好な回転を妨げています。

3. **ポジショニングとリラックス：**

- 位置につき、患者を後ろに倒して自分にもたれさせます。
- 完全にリラックスするように指示します。患者を支えます。
- 親指で支点を作ります。

4. **下降と組織の聴診：**

- ゆっくりと深く下降し始めます。組織を探します。
- 組織を聴診します。患者の呼吸を観察します。呼気時に下降し、わずかな抵抗、ある程度の密度に遭遇します。

5. **安定化と段階的な動員：**

- 安定するために、後方にしっかりと真っ直ぐな支点を取り、ゆっくりと位置につきます。
- 患者が痛みを感じていないことを確認します。
- 服の分だけ少し余裕を持たせて、さらに下降します。
- 患者に非常にゆっくりと体を起こすように指示します。一緒に「ホップ」と持ち上がるのを感じるができます。
- 動きを繰り返します：ゆっくりと持ち上げ、次にリラックスします。少しずつ進めます。
- 時には「ブレーキ」を感じ、少し先に進み、持ち上げたり下げたりして探します。

6. **後方からの把持と感覚：**

- 次に、後方の部分を両手で挟みます。

- 患者に完全にリラックスするように指示します。過度の痛みがないことを確認します。
- 感覚が感じられ、次に「胆嚢のレベルで開く」ことがあります。

7. テクニック後の確認：

- 後方の支点を探し、戻ります。
- 患者に再び頭を左に回すように指示し、可動性を確認します。

テクニック2：大網の後腔と胃の解放

このテクニックは、大網の後腔と食道の付着部に焦点を当てています。横隔膜と関連する**肋骨**の重要性を忘れてはなりません。そこには重要な集中があります。

実践プロトコル

1. **位置特定：**「穴」ができる場所に位置します。
2. **手のポジショニング：**手を平らにして、第7、第8、第9肋骨のレベルで接合部に向かって置きます。
3. **滑らせてリラックス：**手を下に滑らせて平らに置きます。次に、もう一方の手を添えます。
4. **てこの原理：**リラックスして、小さいてこの原理を作ります。この領域は緊張の重要な交差点です。
5. **効果：**
 - 胃と噴門の接合部全体を解放します。
 - トレイツ筋の筋肉領域と関連構造を弛緩させます。
 - この重要な関係に作用します。

全体的な感覚と胃後嚢

- より全体的な感覚に集中します。全身に触れます。
- **胃後嚢**は非常に重要であり、動員する必要があります。潰瘍はしばしば後方にあり、この嚢は良好な蠕動運動と機能のために可動性が必要です。自由でなければなりません。
- 自由でない場合、横隔膜に対して解放されていません。

必須の解剖学的関連性

- 食道と胃は、頭蓋底と関連する最初の臓器です。
- それらは**後方中胃**、角、左主気管支と関係があります。熱が上昇し、次に下降するのを感じることができます。

生体力学的アプローチと胚発生

私は今、別のレベルを探求しています：**胚発生**の力、支え、力強さです。呼吸を観察し、横隔膜と後方肺領域の間により多くの空間を与えることを目的とした筋膜の働きを感じ取ります。

腹膜面

- 腹膜面では、**左結腸曲**が腹膜全体の発生における最初の固定点です。これが最初の支点です。
- この支点に集中し、次に可動点に集中します。
- 最も可動性の高い点は**盲腸**であり、最後に配置されます。それがどのような状態であるかを評価します。
- 両手の間に、結腸の回転軸全体があります。横隔膜はこれらの構造に作用します。
- この空間には、**鎌状靭帯**のようなすべての靭帯があります。

治療の選択

施術者は何に取り組むかを選択できますが、多くの場合、患者の身体がこの選択を導きます。

- 例えば、鎌状靭帯、またはその葉の緊張。
- 時には、「優しい怒り」の表現があり、まるで後方の支点が不足しているか、ここに解放が必要であるかのように感じられます。
- この作業は、小脳テント、大脳鎌、**鶏冠**のレベルで、脳のテントと同期して行われます。洞に作用します。

生体力学における怒りの表現

怒りは、ある時点での表現の無能力として現れることがあります。それは、言えなかったことに関連して、長い間続いている可能性があります。生体力学では、全体性に身を置くことでプロトコルを把握します。胸式呼吸を離れ、空間に入り、それを開いたままにします。すると、身体が私を支点へと導きます。「フラッシュ」が現れ、緊張を示唆することがあります。

生体力学的アプローチの鍵（イニシエーション）

- 水に飛び込む（比喩的に）。
- 動きを聴く。
- 動きを感じる。
- **バランス**（平衡点）を探す。
- バランス点を見つけたら、その背後にある静寂を聴く。

細胞が「応答」し、受容に開かれるとき、それは細胞の「**点火**」です。

注意事項と手のポジショニング

横隔膜に取り組む際には、横隔膜に空間を与えることが重要です。

避けるべき間違い

- **頭を押す**：両手の間に均等な感覚が必要です。大きな間違いは、患者の頭を押すことであり、これは長期的には非常に不快です。
- **悪い姿勢**：肘をしっかりと支えましょう。

ポジショニングのヒント

ニンニクを食べていると想像し、適切な空間を取ります。適切な空間を見つけることが重要です。

瞑想的なガイダンスとセラピストの状態

この実践では、**瞑想的な状態**へと導きます。

- 適切な位置に身を置きます。
- 受け手として、その位置の感覚を定義してみてください。

触覚の感覚

触覚は非常に軽く、多くの温かさを伴います。それは全体的であり、足まで広がっているように感じられます。同時に、「**微結晶場**」を捉えているような感覚があります。これらすべての細胞、その小さな細胞ネットワークと受容体です。それは巨大な場です。

グリコカリックスの場

グリコカリックスの場の情報が最も集中している場所は、**十二指腸の第2部**、つまり腸の最も情報量の多い部分です。この場は全身に存在し、すべてを包み込む全体的な場として機能します。これにより、深い接触を確立することができます。